BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo II



Saúde do trabalhador e a covid-19

GPST Grupo de Pesquisa Subjetividade e Trabalho
CNPq
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Thaís Augusta de Oliveira Máximo
Tatiana de Lucena Torres
Adson Cunha
Marcus Carvalho
(Coordenadores)

BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo II



Saúde do trabalhador e a covid-19

Boletim de resultados do Estudo II é uma publicação do projeto Saúde do trabalhador e a covid-19

Núcleo de Comunicação
Coordenação e edição de texto: Suéllen Rodrigues
Projeto gráfico e arte: Gabrielly Nascimento

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENADORA
Thaís Augusta de Oliveira Máximo

VICE-COORDENADORA
Tatiana de Lucena Torres

NÚCLEO DE PSICOLOGIA
Amanda Wanderley Leite de Sousa
Ana Luisa Adissi Machado
Daniely Jéssica Tenório Santana
Elza Maíza de Assis Vaz
Erick Idalino Moura
José Ulisses do Nascimento
Lígia Lima Ferraz
Linniker Matheus Soares de Moura
Lucas Eurikes Melo Vasconcelos
Maria Beatriz Franco de Medeiros
Maria Eduarda Dias Gomes
Maria Luiza Benício Lopes
Rian Enedino Pereira Cruz
Valéria Nicolau de Sousa
Wesley Jordan Pereira da Silva

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
José Adson Oliveira Guedes da Cunha
Marcus Williams Aquino de Carvalho

NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Arthur Silva Cavalcante Ferreira
Beatriz Maciel de Souza
Gabriel Ribeiro Dias
Jhonatas Flor de Sousa
Relbert Ruan Marculino de Medeiros
Walterlly Nicolau de Sousa

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Suéllen Rodrigues Ramos da Silva

NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO
Maurício de Melo Apolinário Júnior
Rayssa Beatriz Oliveira



APRESENTAÇÃO

Este boletim apresenta resultados gerais do segundo estudo do projeto “A saúde dos/das trabalhadores/as da saúde no contexto da pandemia da covid-19: prevenção e cuidado” (Universidade Federal da Paraíba/CNPq).

O Estudo II foi realizado remotamente a partir de entrevistas aplicadas on-line, por videochamada, entre os meses de julho e novembro de 2021. As entrevistas seguiram um roteiro semi-estruturado, ou seja, constituído por perguntas pré-estabelecidas, com a possibilidade de inserir outras questões no decorrer, quando necessário. Teve como participantes trabalhadores/as da saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com atuação no enfrentamento à covid-19 em estados da região Nordeste. É possível conferir os resultados das análises do Estudo I clicando aqui.

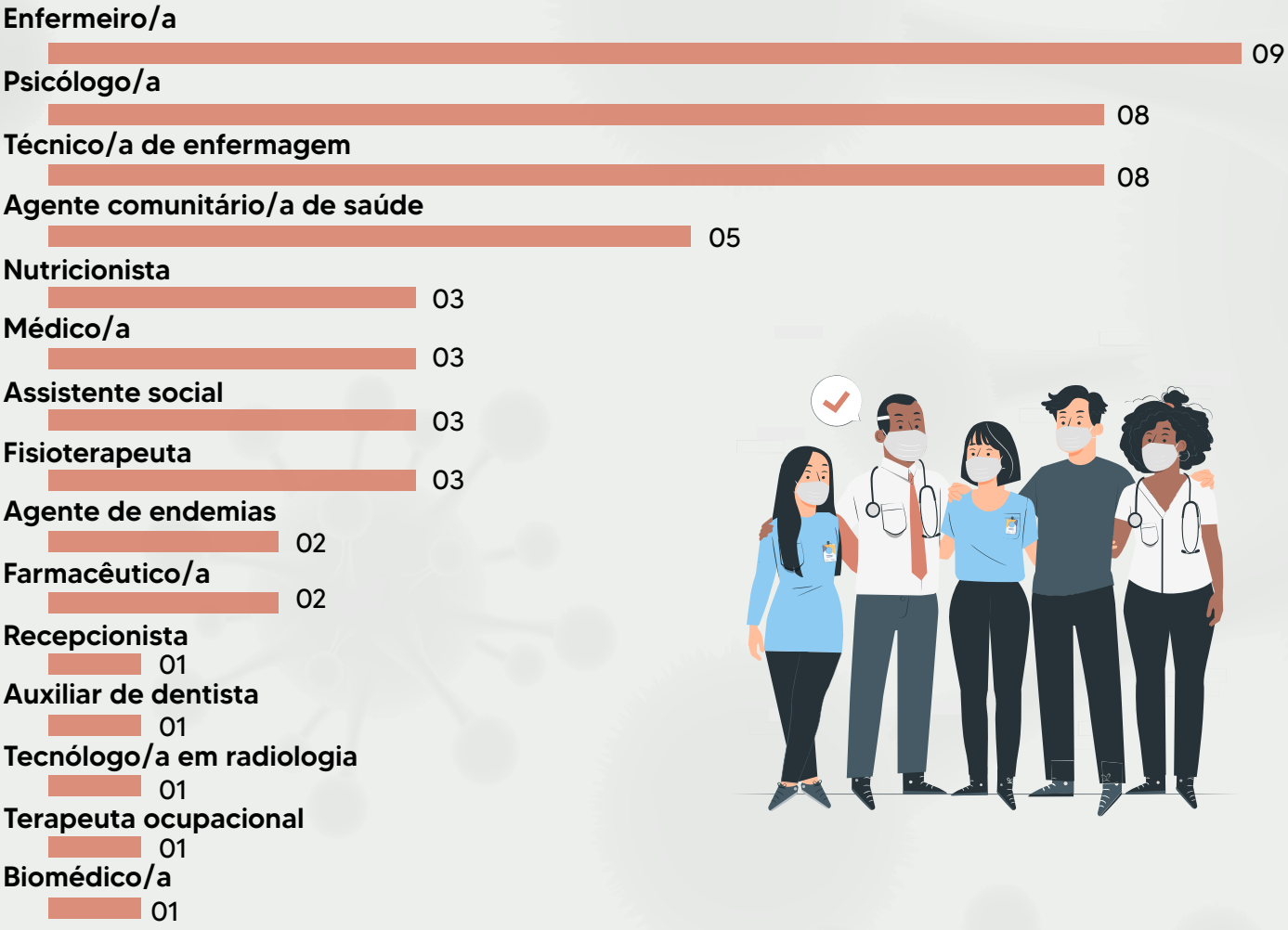
Foram realizadas 51 entrevistas, com profissionais de diferentes estados do Nordeste: 13 participantes da Paraíba; 9 participantes de Pernambuco; 8 do Rio Grande do Norte; 7 do Ceará; 4 do Maranhão; 4 do Piauí; 2 da Bahia; 2 de Alagoas; 1 de Sergipe; e um/uma profissional que atuou simultaneamente nos estados do Ceará e do Piauí. A maioria é do sexo feminino, sendo 39 trabalhadoras e 12 trabalhadores, distribuídos nas seguintes profissões (Gráfico 1):

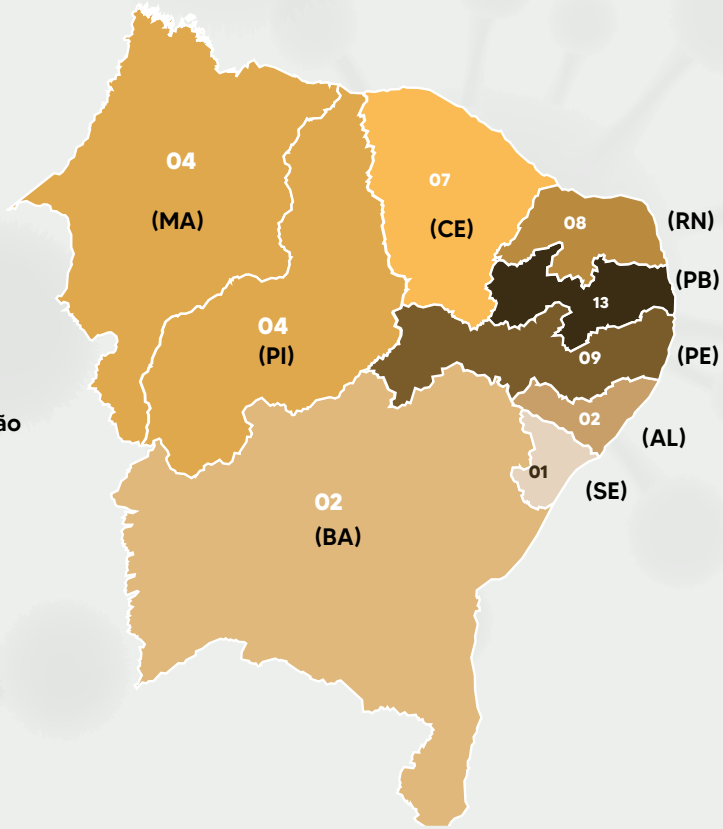


Gráfico 1. Profissão

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

nº de respondentes





Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

- Paraíba
- Pernambuco
- Rio Grande do Norte
- Bahia
- Ceará
- Alagoas
- Maranhão
- Piauí
- Sergipe

Obs.: 01 profissional atuou simultaneamente nos estados do Ceará e do Piauí

MÉTODO DE ANÁLISE



As entrevistas realizadas foram gravadas e transcritas e, ao partir para a análise, as respostas de cada participante foram subdivididas conforme os temas de cada pergunta. A análise das entrevistas teve o auxílio do software Iramuteq, um programa de análises de texto que permite organizar as narrativas em diferentes temas. Posteriormente, essas categorias são interpretadas pelos/as pesquisadores/as a partir da leitura dos trechos e a identificação dos sentidos e significados.

1 IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19

2 CONDIÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

3 TRABALHO REAL E PROCESSOS DE TRABALHO

4 PRAZER E SOFRIMENTO

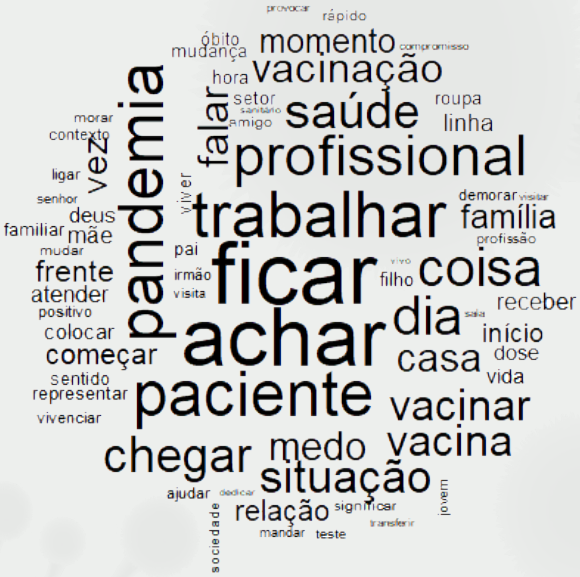
5 SAÚDE E SEGURANÇA

ANÁLISE DOS CONTEÚDOS TRAZIDOS NAS ENTREVISTAS

1
IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19

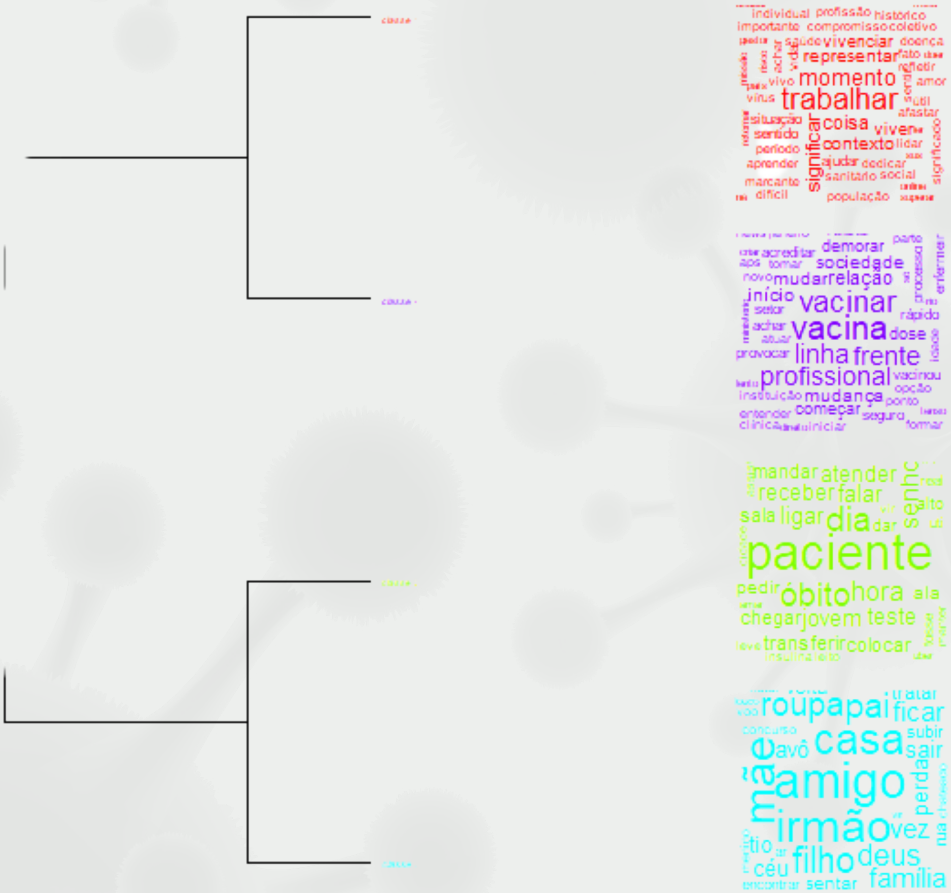
Esta seção compila os temas relacionados a questões que envolvem a atividade de trabalho e a pandemia, enfatizando os aspectos associados às mudanças que ocorreram nos processos de trabalho durante esse período. A seguir, discutiremos as principais classes de sentido encontradas.

Figura 1. Nuvem de palavras do tema “Impactos da pandemia da covid-19”.



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Figura 2. Dendrograma com as nuvens de palavra de cada classe. Perceba que aqui cada classe possui uma nuvem de palavras diferente. A Figura 1 tem a nuvem de palavras considerando todo o recorte da análise da primeira categoria.



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

O trabalho em saúde durante a pandemia



Esta categoria compreende os sentidos, significados e vivências de trabalho na linha de frente no combate à covid-19. As falas dos/das trabalhadores/as que remetem a esse contexto envolvem o compromisso, a responsabilidade e a dedicação assumidos pelos/as profissionais de saúde, compromisso com os/as pacientes e com a saúde pública, objetivo de oferecer ajuda humanitária. Apesar desses significados, esse momento de trabalho causa medo e é sentido como muito difícil para esses/as trabalhadores/as. Nessa perspectiva, o trabalhar na pandemia é visto como um desafio, um momento de superar os limites, por exigir tanto comprometimento, dedicação e pela relevância social da atividade que desempenharam durante um período de tantas incertezas.

Os aspectos apontados como positivos pelos/as trabalhadores/as dizem respeito à possibilidade de ajudar o próximo, de se perceberem e serem percebidos como essenciais e úteis, assim como a possibilidade de aprender no contexto da pandemia, de ter orgulho em ser profissional da saúde e de enfrentar o desafio de trabalhar nesse contexto.

Esses/as trabalhadores/as da saúde também relatam a necessidade de um trabalho digno, ou seja, com equipamentos de segurança e condições de trabalho adequados, pois a pandemia é um momento que não se pode perder de vista os riscos que podem levar à morte do/da profissional. Nesse sentido, alguns/algumas trabalhadores/as relatam que trabalhar na pandemia significa “sobreviver”.

Vivências de sofrimento: o isolamento, o luto e o preconceito

Nesta classe, as falas dos/das trabalhadores/as abarcavam vivências de sofrimento causadas pelo isolamento de amigos e da família. O constante medo de contaminar seus amigos e familiares é uma das causas da diminuição de contato social

fora do contexto de trabalho e da falta de momentos de lazer.

Além disso, o luto pela morte de pessoas conhecidas durante a pandemia se tornou algo do cotidiano de trabalho, caracterizando o momento pandêmico, o que lhes causa sofrimento. Nos trechos das entrevistas que esses temas surgem, os/as participantes rememoram as situações de internação e de morte de amigos, membros da família, familiares de pacientes e pacientes.

Os/as trabalhadores/as também expressam as situações de preconceito e discriminação que sofreram durante a pandemia. Em alguns espaços, a identificação a partir dos uniformes utilizados por eles/as ocasionava certo estigma, que fazia com que as pessoas se afastassem, sentissem medo.

O início da vacinação



Para os/as entrevistados/as, o início da vacinação alterou o processo de trabalho, a relação da equipe e permitiu o desenvolvimento de um maior senso de segurança. Porém, eles/elas relatam que a vacinação iniciou tardiamente e que ainda existiam muitas incertezas referentes ao comportamento do vírus e ao tempo para que a vacinação barrasse a propagação da doença.

O início do processo de vacinação permitiu a diminuição do medo e da tensão no trabalho e o aumento da segurança. Alguns/algumas profissionais relatam uma diminuição na disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPIs), revelando que a escassez de equipamentos deu-se por diferentes causas no decorrer da pandemia — se, no início, essa escassez de insumos era motivada pela alta demanda, com o início do processo de vacinação aparece a flexibilização por parte da gerência da instituição na disponibilidade de insumos. Esse relaxamento com relação às medidas de segurança foi observado tanto por parte da gerência como por alguns/algumas trabalhadores/as, pacientes e população em geral.

Outro ponto diz respeito à racionalização e aos critérios utilizados para selecionar quais profissionais seriam vacinados/as. Os/as profissionais relatam certa contradição em relação aos/às trabalhadores/as considerados como "linha de frente". Segundo eles/elas, a escassez de vacinas não permitiu a vacinação de todos/das os/as profissionais que atuavam na rede de saúde simultaneamente, e, em algumas situações, aqueles/as que não atuavam diretamente com a covid-19, mas em outras funções da área da saúde, eram vacinados antes daqueles/as com tal atuação.

Trechos das entrevistas do Estudo II sobre "Impactos da pandemia da covid-19"

"Trabalhar durante a pandemia é sobreviver. Significa sobreviver, com certeza. Significa muita responsabilidade. Significa muito compromisso. Muito sentido, exige muito sentido do que você está fazendo. Um sentido que extrapola questões individuais, mesmo." (mulher, assistente social, atenção básica)

"Isso foi bem difícil, vieram vários dilemas, porque não que ninguém da minha equipe estivesse se recusando a trabalhar, mas a gente queria trabalhar com o mínimo de segurança." (mulher, biomédica, média complexidade)

"Para mim, não foi apenas marcas positivas, porque infelizmente a gente teve inúmeras mortes e eu vivenciei isso. A gente teve colegas que vieram a óbito, poucos, mas, por exemplo, a gente teve um colega em especial." (mulher, psicóloga, alta complexidade)

"Isso chamava muita atenção, essa imprevisibilidade que essa doença trouxe e que colocava a gente diante dessa incerteza, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Acho que isso foi uma marca para a vida." (mulher, psicóloga, alta complexidade)

"E aí acho que uns dois meses depois começou a se vacinar os agentes comunitários de saúde, mas teve cidade aqui próximo que chegou a passar uns cinco, seis meses sem vacinar, porque dizia que o agente comunitário de saúde não era linha de frente." (mulher, agente comunitária de saúde, atenção básica)

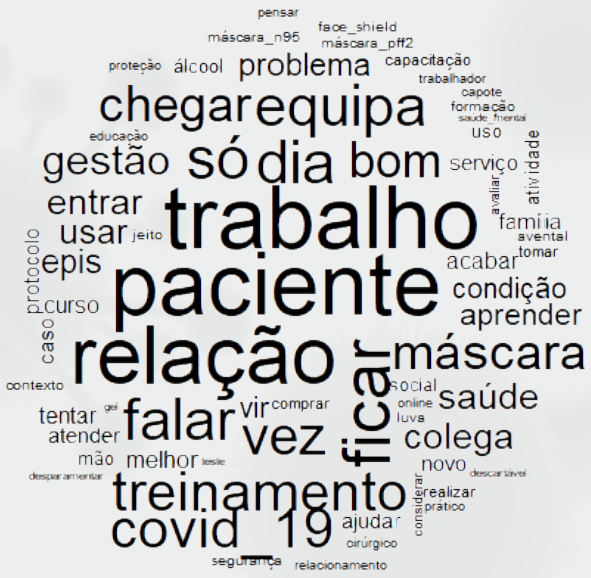
"Porém, eu reconhecia que o meu continuar trabalhando, de certa forma, era ajudando os meus colegas. Então isso me alimentava também, quando eu via que estava ajudando, quando eu via que estava sendo útil, de certa forma." (mulher, psicóloga, média complexidade)

"A situação que representa a pandemia para mim é quando penso na quantidade de óbitos e de corpos que a gente via saindo dos setores." (mulher, nutricionista, alta complexidade)

2
CONDIÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Esta seção expressa conteúdos referentes às preocupações com as condições ofertadas pelas instituições para que os/as profissionais realizassem seu trabalho, bem como formas de organização deste durante a pandemia.

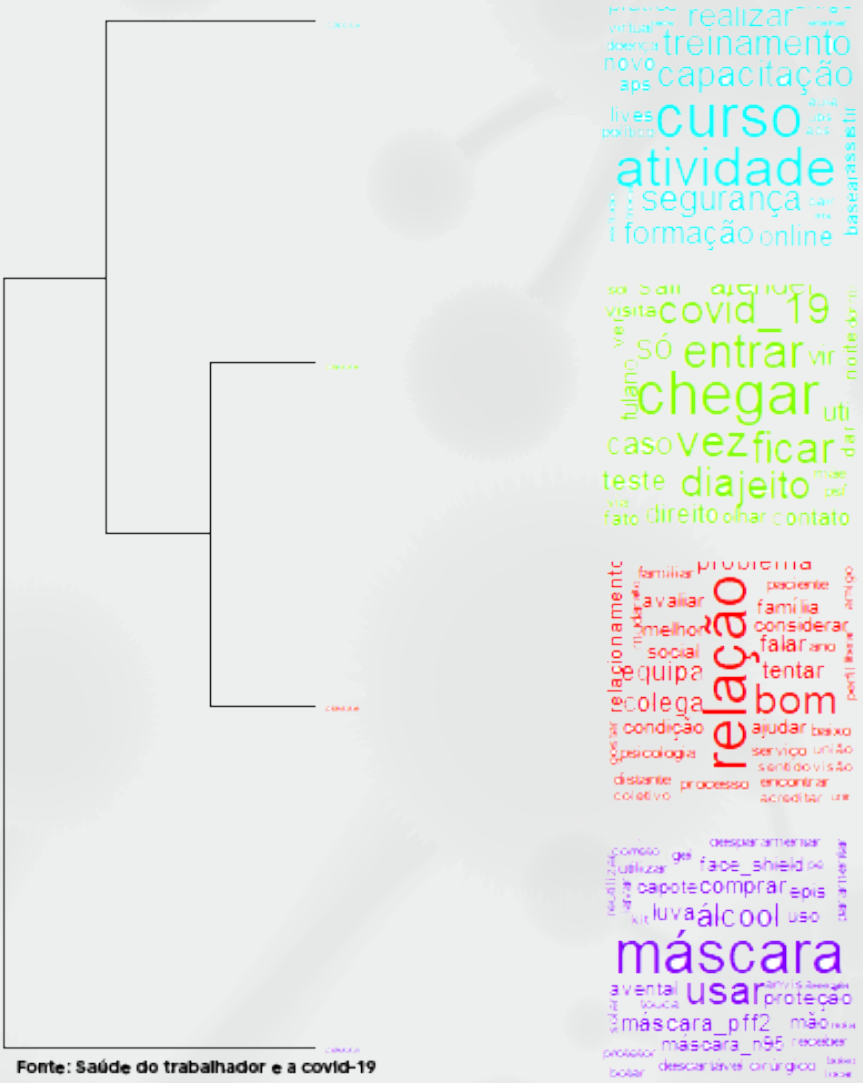
Figura 3. Nuvem de palavras do tema “Condições e organização do trabalho”



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Figura 4. Dendrograma com as nuvens de palavras de cada classe (seção).





Relações de trabalho como fatores protetivos de saúde

As falas presentes nesta classe retratam os diferentes tipos de relações no trabalho: entre os/as próprios/as trabalhadores/as, pacientes, familiares de pacientes e com a gestão. No geral, as relações de trabalho são avaliadas positivamente pelos/as profissionais, bem como a relação com os/as pacientes e familiares.

Com pacientes e familiares, é observado o esforço em superar as dificuldades impostas pelas condições de trabalho e a busca em prestar um serviço de qualidade numa perspectiva de melhora contínua. Durante a atuação, os/as trabalhadores/as desenvolvem um senso de coletividade, possibilitando a criação de estratégias de enfrentamento coletivas.

No que concerne à gerência das instituições de saúde, esta é descrita como hierarquizada e oferecendo pouco reconhecimento aos/as trabalhadores/as: há a existência de conflitos desencadeados por falhas de processos e ferramentas, problemas de comunicação e a luta por melhores condições de trabalho.

Condições de trabalho na covid-19

Os/as entrevistados/as abordaram os aspectos relacionados à exposição ao risco de contágio no trabalho em saúde durante a pandemia da covid-19. A atividade de trabalho durante esse período é marcada por mudanças e por imprevisibilidades da chegada e da falta de EPIs e de medicamentos, de protocolos, de informações, treinamentos e educação continuada.

Existe uma diferenciação na oferta desses equipamentos e serviços a depender do tipo de atividade em razão de hierarquização dos/das profissionais e dos chamados riscos profissionais: certas categorias são vistas com mais risco do que outras.

A falta de protocolos para as funções realizadas leva aos/às trabalhadores/as a cometerem “erros”, fazendo-se necessária a construção coletiva de uma prescrição informal da atividade, a fim de otimizar o atendimento e minimizar os riscos para si e para outras pessoas.

A sobrecarga de trabalho é evidenciada em algumas falas em que os/as trabalhadores/as sentem que acabam acumulando muitos conflitos e frustrações, ao passo que, nesse cenário, não são ofertadas ações em saúde mental que consigam dar conta desse sofrimento.

A formação para atuar no combate à pandemia

Foram abordadas questões relacionadas à formação, nas quais os/as trabalhadores/as relatam que a busca por capacitação acontece por iniciativa dos/das próprios/as trabalhadores/as, uma vez que existe pouco ou nenhum incentivo a respeito. Os cursos e capacitações acessados pelos/as trabalhadores/as individualmente são majoritariamente on-line e gratuitos.

Os treinamentos ofertados pela gerência aconteceram durante o início da emergência pública e não acompanharam as necessidades que surgiam no decorrer da progressão da pandemia. Os/as entrevistados/as relatam dificuldades no acesso aos treinamentos, capacitações e à educação continuada, e a falta de treinamento é vista como um risco, para si e para as outras pessoas.

Não era para todo mundo: equipamentos de proteção

Por fim, esta classe expressa falas preocupadas com os EPIs, evidenciando o acesso precário a estes, como máscaras, luvas, capotes, álcool, face shield (protetor de rosto), avental. A falta, o racionamento e a má qualidade dos EPIs disponibilizados pela gestão fazem com que os/as trabalhadores/as necessitem comprá-los e/ou reutilizá-los de modo a manter a sua proteção no trabalho e minimizar os riscos de contágio. Os/as trabalhadores/as relatam que o acesso às máscaras apropriadas para a proteção ao coronavírus difere a depender da atividade, havendo relato de um trabalhador no qual menciona que “a máscara N95 não era para todos”.

Os/as respondentes ainda afirmam ter acesso ao básico: recebiam as máscaras em pouca quantidade e tinham que usá-las por um grande período, o que não corresponde às demandas reais da atividade de trabalho. Em relação a esses aspectos, os/as trabalhadores/as relatam o suor, o odor, o calor e os machucados como pontos que dificultam o uso desse EPI por tempo prolongado e sem trocas.

Trechos das entrevistas do Estudo II sobre "Condições e organização do trabalho"

"Enquanto equipe, a nossa relação de trabalho é muito boa, com os pacientes também. Com a gestão a gente sempre bate de frente, porque a gente solicita o EPI e nunca tem o retorno." (homem, agente comunitário de saúde, atenção básica)

"Na verdade, a equipe é a vivência de prazer que eu tenho no meu trabalho. Porque eu amo minha equipe, minha equipe é muito boa, é muito entrosada, é o que mais me traz satisfação." (mulher, enfermeira, alta complexidade)

"[...] se eu não fosse procurar, eu ia estar colocando em risco a minha vida e a vida do paciente. Então eu realmente tive que buscar cursos, leituras, formações para isso." (mulher, técnica de enfermagem, alta complexidade)

"[...] e outros treinamentos também não houveram. É assim: cada um por si e Deus por todos, nesse sentido. Eu aprendi a realizar minhas atividades em relação à doença da covid-19 sempre procurando estar muito atenta ao que era publicado de artigo, sempre. Foi assim que a gente aprendeu, e na troca, na prática, na troca de experiências com outros colegas que lidavam." (mulher, médica, alta complexidade)

"[...] eu acabei comprando um pacote de máscaras pra mim da máscara N95, porque eu acabava revezando, um dia eu usava a do município, outro dia eu usava a minha e ia higienizando, então eu acabei comprando porque a do município tinha que ficar muito tempo e não é uma máscara para você usar tanto tempo [...]" (mulher, enfermeira, alta complexidade).

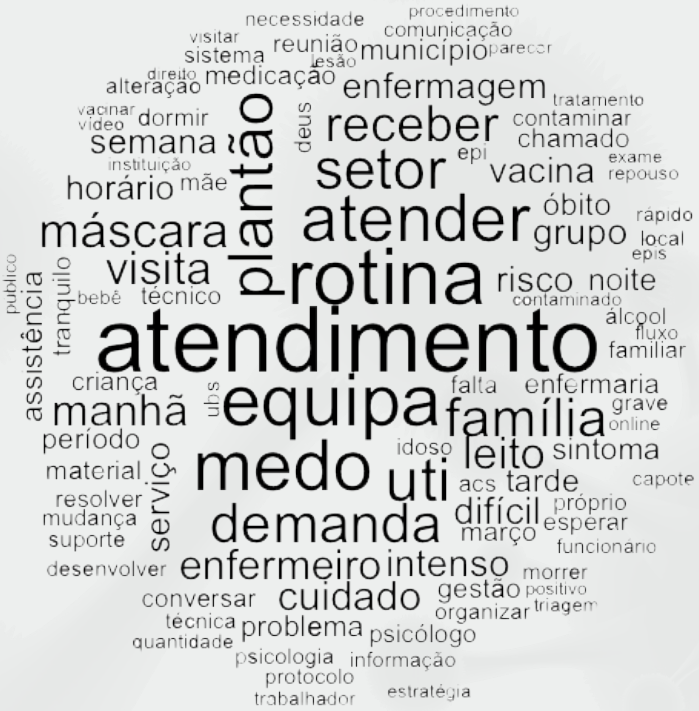
"E EPI também tinha dia que tinha, tinha dia que não tinha o básico, tipo a máscara, a luva, o capote, tinha dia que tinha e tinha dia que não tinha." (mulher, técnica de enfermagem, média complexidade).

"No início, foi uma luta, porque até eu tirei foto da máscara, que parecia esses paninhos do mosqueteiro." (mulher, agente comunitário de saúde, atenção básica).

3
TRABALHO REAL E PROCESSOS DE TRABALHO

Nesta seção, é tratado o dia a dia de trabalho dos/das profissionais entrevistados/das, incluindo tópicos como a história de trabalho no contexto da pandemia, descrição de um dia típico de trabalho, bem como alterações na rotina após a pandemia.

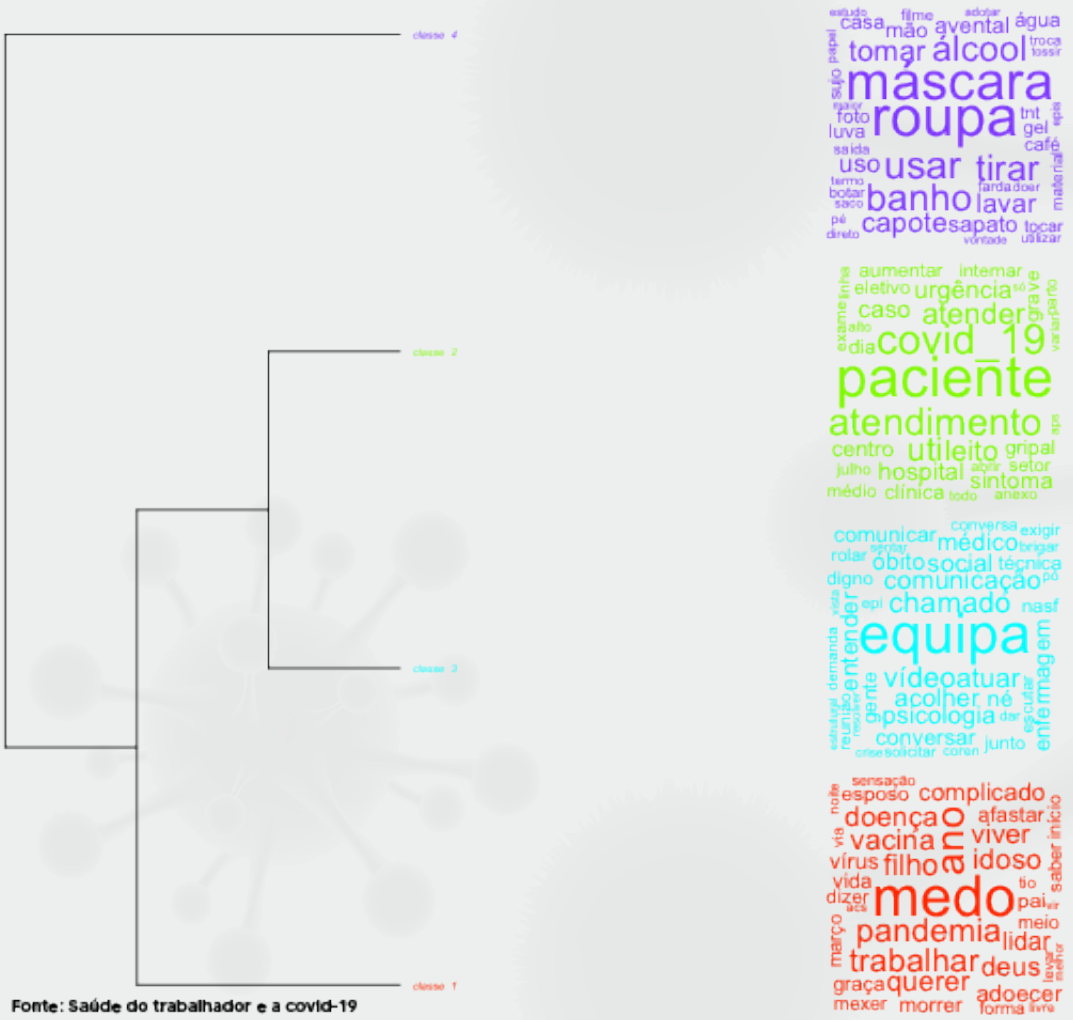
Figura 5. Nuvem de palavras do tema “Trabalho real e processos de trabalho”



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Figura 6. Dendrograma com as nuvens de palavra de cada classe.



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Medo e família

As falas tratavam do medo constante de contaminar alguém da família, revelando uma carga mental que impedia o descanso mesmo quando estavam em seus lares. Foi comum o relato de convívio com pessoas vulneráveis, como idosos e crianças ou bebês, o que potencializava ainda mais a preocupação.

A vacina surge nesse cenário como uma esperança para proteger não só quem está na linha de frente, mas também os seus familiares. Aqui, é importante salientar que que os/as profissionais participantes da pesquisa não se reduzem às especialidades da área da saúde, mas abrangem todos/as os/as profissionais que atuam nas instituições, como recepcionistas, motoristas, maqueiros e trabalhadores/as de serviços gerais.

Reestruturação do atendimento de urgência

As modificações sobre a estrutura do atendimento de urgência também foram um dos pontos apresentados, que trata sobre a remodelação do ambiente de trabalho para comportar a quantidade de pessoas em estado crítico. Essa categoria contém falas sobre a quantidade de leitos específicos para pessoas com covid-19, bem como a lotação dos mesmos.

Nesta classe, fica evidente o esforço em adaptar o ambiente hospitalar a partir das demandas, da forma mais rápida possível. Um exemplo disso é a estratégia de transformar um ambulatório ou clínica em hospitais que atendem exclusivamente infectados com o coronavírus. Esse cenário evidenciou a quebra da rotina dos/das trabalhadores/as e a necessidade de readaptação para se adequarem à nova demanda.

Comunicação

Os/as trabalhadores/as relatam a importância do diálogo entre a equipe, assim como com a família dos/das pacientes e os desafios presentes nessa comunicação. Sobre a família, foi frequentemente descrita a necessidade de acolher o sofrimento dos familiares do/da paciente, formas de comunicar o óbito e a realização de chamadas de vídeo. Esse último recurso se revelou um importante fator promotor de bem-estar dos/das pacientes internados/as.

Quanto à comunicação de óbitos, muitos/as participantes descreveram que essa função era realizada por meio de um/uma profissional de medicina acompanhado/a de

profissionais da psicologia e assistência social. Em alguns casos, houve o relato de que a comunicação do óbito se dava por telefone, sem o apoio técnico imediato.

A comunicação entre a equipe acontecia de forma bastante atribulada devido à demora em estabelecer um protocolo unificado, formação precária, dificuldade de realizar reuniões e a inserção abrupta de novos/as profissionais.

Paramentação e desparamentação

O processo diário e cauteloso de colocar os EPIs necessários também foi um dos aspectos citados pelos/as profissionais da saúde. No início do dia, muitos relatam vestir a roupa na instituição em que trabalham em um ambiente designado para esse fim. Os equipamentos descritos eram capote, óculos, touca e máscara N95, e havia necessidade de higienização constante com álcool etílico 70%.

No processo de voltar às suas casas, foram relatadas diversas estratégias para minimizar os riscos de contaminação aos demais moradores da residência. Algumas destas foram: tomar banho em uma área externa da casa, lavar as roupas imediatamente com desinfetante e usar sempre máscara dentro de casa. Esse processo demonstrou ser muito desgastante e foi comum o relato de sentir vontade de negligenciar algum cuidado devido ao cansaço.

Dessa forma, os/as trabalhadores/as relataram rotinas bastante desgastantes e a necessidade de desenvolverem estratégias próprias para protegerem a si mesmos e aos seus familiares, também em conjunto com a equipe da instituição para resolver as novas demandas da melhor forma. Nesse processo, o medo de errar na proteção ou na execução de suas tarefas foi bastante presente, afetando o bem-estar dos/das trabalhadores/as.



Trechos das entrevistas do Estudo II sobre Trabalho real e processos de trabalho

"Tive medo de contaminar os familiares, medo de sair de casa, medo de contrair a doença, então começou a chegar muito essas demandas de não querer mais trabalhar, de querer abandonar o emprego [...]." (mulher, psicóloga, média complexidade)

"Eu tinha medo de eu ser a culpada por minha mãe, ou até mesmo eu, morrer e deixar um filho. Eu ficava entre a cruz e a espada, na verdade, no início de tudo." (mulher, técnica de enfermagem, atenção básica)

"Minha mãe é hipertensa, tem 60 anos, é fumante. Meu filho tem bronquite, aí era uma coisa que vinha muito peso para mim, e assim eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa e eles [a instituição] não iam nem me dar assistência." (mulher, técnica de enfermagem, atenção básica)

"Todas as atividades ambulatoriais foram suspensas e aí os/as pacientes não tinham mais atendimento ali e os/as profissionais foram direcionados, realocados em algum lugar, e esse ambulatório foi transformado em um hospital covid-19." (mulher, enfermeira, média complexidade)

"Na pandemia, ficou todo mundo plantonista, onde uma pessoa tinha que ficar com cinco setores, mais ou menos. No meu caso, como é emergência, é muito variável a quantidade de paciente, mas digamos que era um setor anexo do covid-19, que era totalmente fechado, tinha mais ou menos 40 pacientes." (mulher, nutricionista, alta complexidade)

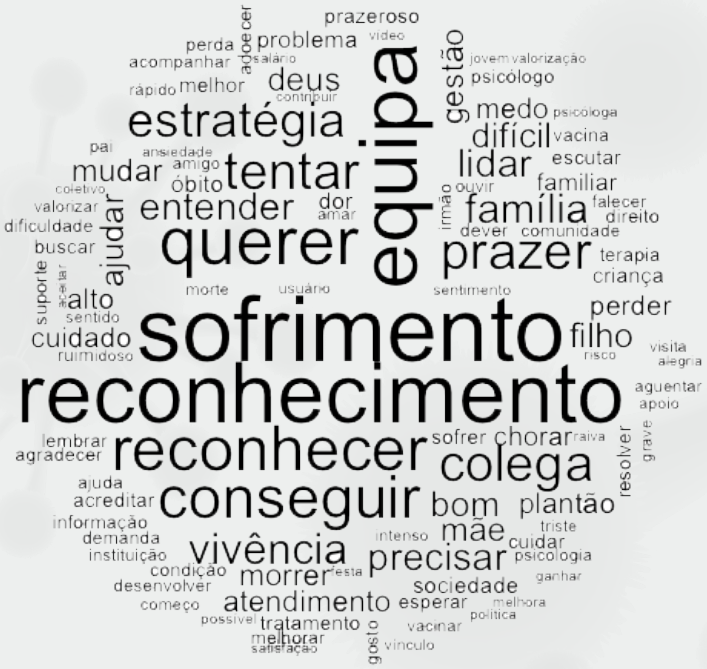
"O médico vem, comunica o óbito, e aí a gente fica para acolher a família pós-comunicação. E é tanto no sentido de dar orientações de forma mais assim burocráticas do que tem que fazer declaração de óbito, etc." (homem, psicólogo, média complexidade)

"Eu chegava pelo quintal, porque na minha casa tem um acesso pela lateral, e lá mesmo eu tirava a roupa que eu já tinha trocado no hospital, tomava outro banho lá atrás mesmo [...]" (mulher, tecnóloga em radiologia, média complexidade)

4
PRAZER E SOFRIMENTO

Esta seção versa sobre os aspectos causadores de sentimentos de prazer (como satisfação ou reconhecimento) ou de sofrimento (como insatisfação e medo) presentes nas atividades dos/das trabalhadores/as.

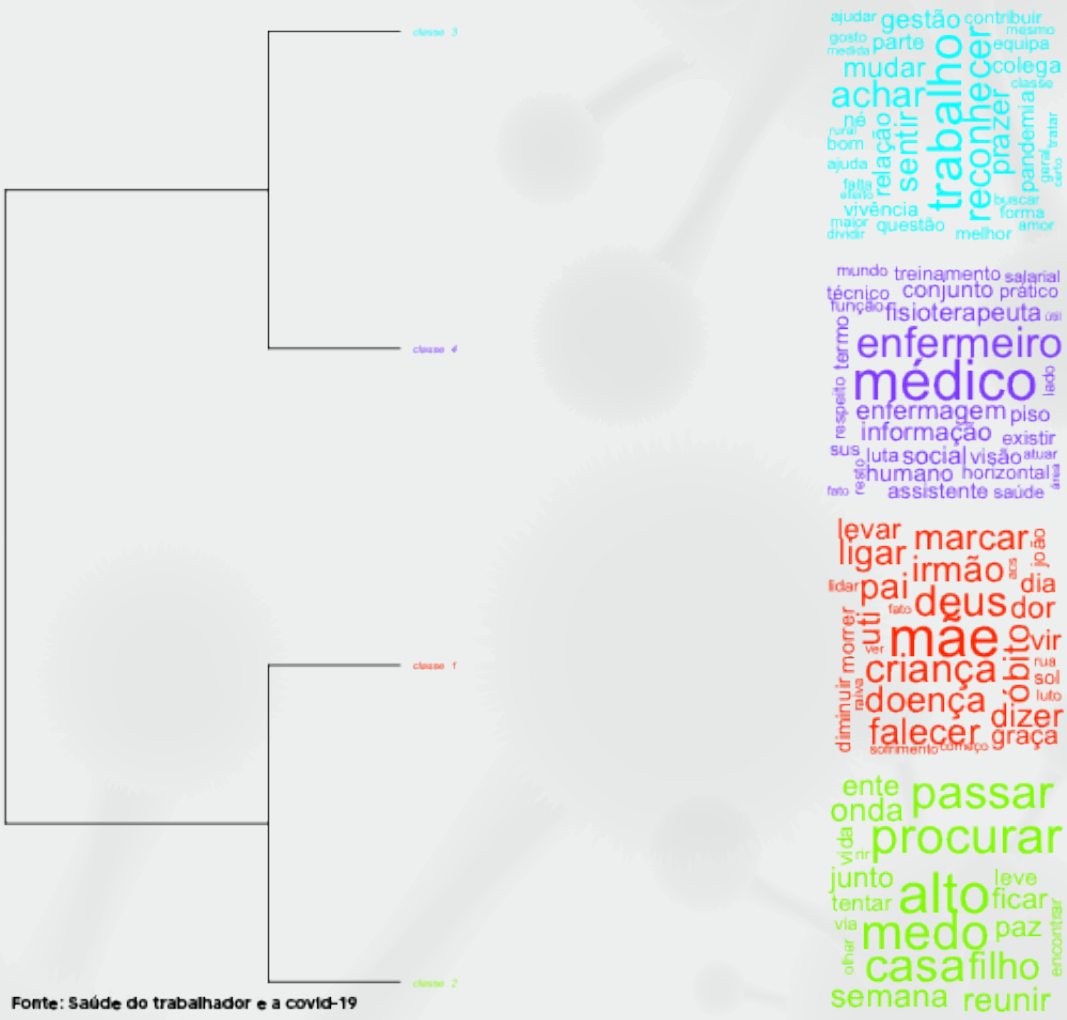
Figura 7. Nuvem de palavras do tema “Prazer e sofrimento”



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Figura 8. Dendrograma com as nuvens de palavra de cada classe.



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Esperança e medo

Os/as trabalhadores/as trazem relatos referentes a sentimentos contrastantes de esperança em relação à cura e ao medo do agravamento da doença. Também mencionam formas de amenizar o sofrimento no ambiente hospitalar, por meio de música e brincadeiras com os/as pacientes. A alta de pacientes internados/as aparece frequentemente como algo que trazia alegria aos/às trabalhadores/as. Esta classe demonstra o investimento emocional do/da trabalhador/a com o/a paciente e sua família, bem como os impactos psicológicos dessa relação.

Sofrimento da família frente ao óbito

Outro aspecto diz respeito a presenciar o sofrimento e a dor experienciados pela família após a perda de um familiar próximo. Os relatos focalizam a angústia desde a chegada do/da paciente, muitas vezes já em estado grave, o óbito em si e a entrega do corpo. A perda de pacientes jovens também acarretava bastante sofrimento nos/nas trabalhadores/as. Ao presenciar essas situações, os/as profissionais relataram mais medo que algo do tipo acontecesse em suas famílias e disseram sentir a necessidade de alertar com frequência seus familiares acerca do perigo da doença.

Prazer através do reconhecimento

Os/as trabalhadores/as relatam que o reconhecimento da sociedade sobre a importância de seu trabalho era fonte de satisfação e falam sobre a atuação na saúde ter tido bastante destaque positivo no período de pandemia, fazendo com que sentissem orgulho de sua ocupação. Porém, apesar desse reconhecimento simbólico, muitos/as trabalhadores/as pontuaram que gostariam de ter também o reconhecimento financeiro por meio das instituições e do estado, bem como melhores condições de trabalho.

O apoio da equipe multiprofissional

As pessoas entrevistadas falaram sobre a relação com os/as profissionais de diversas áreas que compõem a equipe. As falas aparecem de forma tanto positiva quanto negativa — ora a equipe serve de suporte para a atuação do/da profissional, ora se apresenta como um obstáculo. As áreas de atuação mais citadas como parte da equipe foram medicina, enfermagem, fisioterapia, psicologia e serviço social.

A equipe surge como um apoio enquanto serve como auxiliar na formação ao

compartilhar informações e experiências que melhorem a atuação e ao se unir em busca de lutar para conquistar melhores salários e condições de trabalho. Algumas das pessoas entrevistadas criticaram o modelo de saúde que coloca o médico como figura central no serviço de saúde e se sentem desvalorizadas em relação a este, revelando a necessidade de que a instituição reconheça a importância dos/das demais profissionais da saúde.



Trechos das entrevistas do Estudo II sobre “Prazer e sofrimento”

“Assim, só esse up que deu nela, do tratamento que a gente estava dando, era assim, elevava a autoestima de todo mundo na enfermaria, entendeu? E quando ela recebeu alta, foi a maior festa, todo mundo chorou de felicidade, foi muito bonito.” (mulher, enfermeira, média complexidade)

“Não deu tempo dele dizer pelo menos tchau para a mãe dele e, pouco tempo depois, poucos dias depois, a mãe dele faleceu de covid-19.” (mulher, enfermeira, média complexidade)

“[...] as situações de sofrimento no trabalho, eu acho que é mais isso, justamente essa escuta, escutar o sofrimento das pessoas. Gente que perdeu mãe, que perdeu tio, primo. Então acho que essa escuta da dor das pessoas tem sido bem pesada.” (homem, psicólogo, alta complexidade)

“[...] essas relações mudaram durante a pandemia no meu trabalho. Me sinto reconhecida pelos pacientes, pelos acompanhantes, pelos colegas. Não me sinto reconhecida pela gestão.” (mulher, psicóloga, média complexidade)

“Infelizmente não me sinto reconhecida no meu trabalho. A gente da enfermagem é uma classe que infelizmente não é reconhecida. Agora, com a pandemia, ficou até um pouco mais conhecida, mas financeiramente a gente não é reconhecido de jeito nenhum. Heróis da saúde apenas da boca para fora.” (mulher, enfermagem, média complexidade)

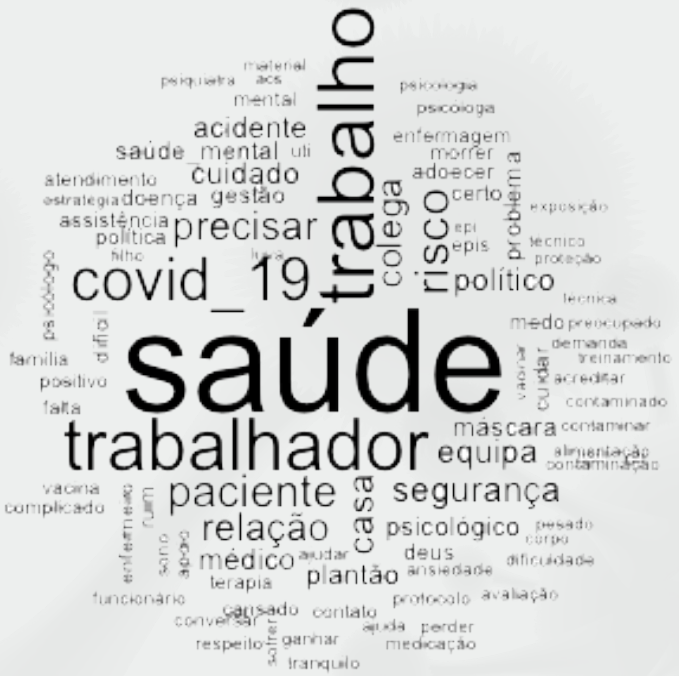
“Ainda não é ainda como deveria ser, mas sabe o que é? Enfermeiro sabe a importância do profissional de saúde, que não é só o médico que existe ali, a gente tem uma equipe multiprofissional que todos estão envolvidos ali.” (mulher, enfermeira, média complexidade)

“Nessa segunda onda, a gente já percebe que muito foi se fragmentando do que a gente construiu na primeira, mas ainda assim se faz festa quando tem alta, entende? Ainda assim se faz pequenas comemorações, nos dias se leva música e faz brincadeira.” (mulher, psicóloga, média complexidade)

5
SAÚDE E SEGURANÇA

Esta seção trata sobre as condições de saúde do/da trabalhador/a, bem como as políticas para garantir seu bem-estar e segurança.

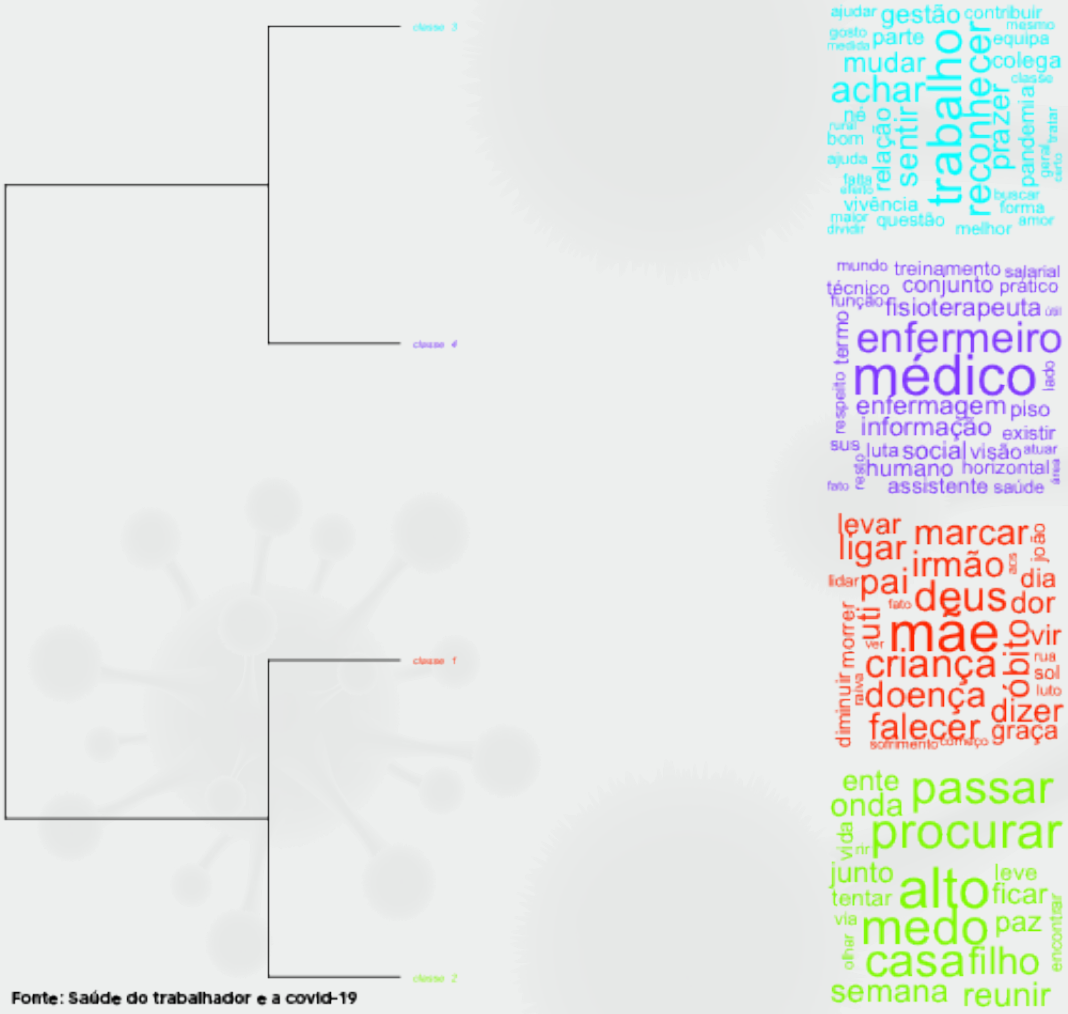
Figura 9. Nuvem de palavras do tema “saúde e segurança”



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



Figura 10. Dendrograma com as nuvens de palavra de cada classe.



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



As demandas do trabalho e o seu impacto no ambiente doméstico

Os relatos indicam a grande carga horária exigida no trabalho na área de saúde e a falta de tempo para dedicação à família. Observou-se diversas falas sobre os plantões e o desgaste de passar dias e noites trabalhando. Esse desgaste frequentemente causava desânimo nos/nas trabalhadores/as e prejuízo ao sono. Relataram também angústia e medo de sair de casa, sendo o lar um ambiente seguro, ainda que houvesse o medo de contaminar os familiares.

Impactos na saúde mental

Os relatos sobre acometimentos à saúde mental causados ou agravados pela pandemia de covid-19 são de ansiedade e depressão. Muitos relataram que o adoecimento psicológico foi o principal acometimento à sua saúde e de seus colegas. Sobre a forma de enfrentamento frente a esse adoecimento, muitos afirmaram ter buscado assistência psicológica por conta própria, procurando atendimento por meio da internet.

Serviços de assistência ao/à profissional de saúde

Sobre a quantidade de políticas de assistência em saúde e segurança direcionadas aos/às profissionais da instituição, ainda que frequentemente relataram haver a oferta de serviços específicos para esse setor, muitos relataram que esta foi insuficiente, fazendo com que o/a trabalhador/a vivesse constantemente com o sentimento de insegurança. Atentam acerca da necessidade de os serviços em saúde tratarem especificamente os adoecimentos do/da profissional da saúde nesse contexto e que se dê de forma acessível e organizada. Por fim, explicitam que a gerência das instituições devem estar atentas às demandas específicas desses/as trabalhadores/as que estão lidando com questões novas ou agravando outras que já existiam.

Situações de risco frente à exposição ao vírus

Os/as trabalhadores/as da saúde relatam a constante insegurança sentida por eles/elas durante o atendimento dos/das pacientes. Por mais que existissem áreas isoladas e demais estratégias para minimizar a exposição, no dia a dia da atividade, aconteciam diversas ocorrências que deixavam o/a trabalhador/a exposto ao vírus. Muitas dessas ocorrências foram relatadas nos serviços de urgência.

Os acidentes mais citados envolviam se furar com as agulhas utilizadas em procedimentos. As demais situações incluíam o mal uso de EPI, tanto por outros/as trabalhadores/as como de pacientes e seus acompanhantes. Isto reforça o constante sentimento de insegurança e medo vivenciado pelos/as profissionais.



Trechos das entrevistas do Estudo II sobre "Saúde e segurança"

"Tem dias de ficar mais mal, tem dias de meu sono, principalmente, que eu comecei a trabalhar no hospital, que eu virei plantonista, plantão noturno, meu sono nunca mais foi o mesmo." (mulher, assistente social, atenção básica)

"Minha vontade é ficar deitada, vendo algum filme, uma coisa bem dentro de casa mesmo. E junta a pandemia e tudo, aí eu não tenho vontade de sair, não tenho saído para lugar nenhum. Fico com medo de me contaminar." (mulher, enfermeira, atenção básica)

"Qualquer profissional da saúde que você conversar se sente desvalorizado, desmotivado. A minha saúde como profissional da saúde, assim, eu acho que o meu desgaste maior sempre foi com a minha saúde mental. Isso me desgastou muito e, graças a Deus, hoje eu estou bem." (mulher, assistente social, atenção básica)

"Eu vou lhe dizer: eu acho que tem que haver ações relacionadas a essas questões de saúde mental. Tem muita gente doente, tem muita gente, colegas com síndromes de pânico, tem colegas meio depressivos [...]." (mulher, enfermeira, alta complexidade)

"Sobre as ações de cuidado, internamente, nós temos o núcleo de assistência ao servidor, que é composto por enfermeiros, médicos, clínicos gerais e psiquiatras, mas os psiquiatras não fazem atendimento, só dão alguma medicação e acompanham, a depender dos sintomas." (homem, fisioterapeuta, alta complexidade)

"[...] porque o pessoal não usa EPI direito, usuários. Aí chegam gripados no lugar, escondendo sintoma para serem atendidos, para chegar no médico, enquanto ele está esperando ali. Se ele tiver com covid-19, ele está transmitindo para os outros né?" (mulher, psicóloga, atenção básica)

"O primeiro caso de médico contaminado, ele foi contaminado porque ele fez uma intubação sem estar com os EPIs, porque a princípio não tinha paciente ainda com covid-19, [...] tava só com o pijaminha cirúrgico, sem máscara e tal, e aí chegou paciente precisando ser intubado e o paciente não podia esperar ele se vestir, e aí ele intubou a pessoa do jeito que tava e foi fazer o teste dele depois e deu positivo, então meio que serviu pra a gente se alertar que o covid-19 tinha chegado." (mulher, psicóloga, média complexidade)

CONCLUSÃO

Em síntese, os/as trabalhadores/as da saúde relataram tensão e angústia vivenciadas no início da pandemia devido à falta de informação acerca da covid-19, o desconhecimento dos procedimentos corretos, insuficiência de equipamentos adequados e o medo de contaminação.

Esses/as profissionais também denunciam a ausência de acolhimento, de diálogo, o esgotamento físico e mental experienciados e enfatizam os desafios de estarem na linha de frente no combate à covid-19. Os momentos de prazer e satisfação no trabalho acontecem quando os/as trabalhadores/as da saúde se sentem úteis por estarem trabalhando na linha de frente e também descrevem o seu trabalho na pandemia como um privilégio e uma oportunidade de aprendizado.

Há um consenso entre os/as entrevistados/as de que todos/as estão fragilizados/as e sobrecarregados/as, especialmente em relação à saúde mental. Sobre às condições de trabalho, os/as profissionais relatam quantidade limitada de EPI, e há um escasso relato de treinamentos direcionados às atividades realizadas durante a pandemia, como condições para paramentação e desparamentação adequadas ou novas funções que surgiam a partir da redistribuição dos/das profissionais, centralizando a aquisição de conhecimentos na experiência do trabalho real.

A presente pesquisa permitiu dar visibilidade às condições de trabalho e riscos aos quais os/as trabalhadores/as da saúde estão submetidos. Salientamos a necessidade de que haja maior atenção e cuidado ao/à trabalhador/a da saúde, com políticas públicas permanentes voltadas especificamente para a prevenção e a promoção da saúde mental e qualidade de vida aos/às mesmos/as, evidenciando a importância da Política de Saúde do/a trabalhador/a.

Nesse sentido, a formação de profissionais das áreas de saúde e segurança do trabalho e gestão de pessoas se traduz como uma iniciativa imprescindível para o cumprimento desses objetivos, partindo de uma perspectiva democrática que resgate e privilegie o lugar de todos/as os/as trabalhadores/as nesse processo.

Portanto, recomendamos a produção de indicadores que possam aferir periodicamente e metrificar os riscos, acidentes, contaminação e morte de trabalhadores/as provenientes direta ou indiretamente do exercício profissional, não

apenas relacionado à covid-19, a fim de fiscalizar e permitir a tomada de decisão quanto a programas e políticas que possam mitigar os riscos.

A criação de protocolo de atenção em segurança e saúde para trabalhadores/as da saúde em situações de calamidade pública, como no caso da pandemia pela covid-19, mas também em situações de desastres, torna-se fundamental.



REDES SOCIAIS E CONTATOS

Instagram: @saudedotrabalhador_covid19

Facebook: fb.com/saudedotrabalhadorcovid19

E-mail: saudedotrabalhador_covid19@cchla.ufpb.br

Twitter: @saudetrab_covid

Endereço: Departamento de Psicologia – Universidade Federal da Paraíba – CCHLA – Bloco Humanístico, Campus I – Castelo Branco I, João Pessoa – PB, CEP. 58051-900



